EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91668
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-29 18:39:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DEL CARMEN CONTRERAS LANDEROS			RUN	: 6.258.092-5
F.Nac	: 25-03-1951	Edad	: 73 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: 11 SEPT ENCINAS 095			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 981557974		
Fecha Ingreso	: 07-08-2024	Fecha Egreso	: 2024-08-29 18:39:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A48.0-GANGRENA GASEOSA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

GANGRENA PIERNA IZQUIERDA
AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA IZQ CON NECROSIS DE MUÑON
VASCULITIS CRIOGLOBULINEMICA MIXTA ANCA (-)
HTA
DIABETES MELLITUS CON COMPLICACIONES CRÓNICAS
ERC EN HD
EPOC GOLD B
OBESIDAD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A48.0-GANGRENA GASEOSA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE VASCULITIS, HTA, DM2 IR
SE REALIZA ESCARECTOMIA EN ULCERA DE CARA POSTERIOR DE LA PIERNA IZQUIERDA. ACTUALMENTE CON GANGRENA EN CARA ANTERIOR Y POSTERO MEDIAL, DE MUY MAL OLOR.
TIENE INDICACIÓN DE AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA
PIERNA CON ULCERA EN CARA POSTERIOR Y CARA ANTERIOR. CON GANGRENA Y MAL OLOR.
SE REALIZA AMPUTACION SUPRACONDILEA PIERNA IZQUIERDA EL 07/08. LUEGO CON EVOLUCION REGULAR DEL MUÑON, PRESENTA NECROSIS DE BORDE POSTERIOR DE HERIDA QUIRURGICA.
ADEMAS CON ITU CON UC + PARA KLEBSIELLA SE AJUSTA TTO ATB A CEFTAZIDIMA COMPLETANDO 2 SEMANAS.
DADA DE ALTA POR CIRUGIA, PARA CONTROL METABOLICO Y DE VASCULITIS EN SERVICIO DE MEDICINA, PERO CON HDA OPERATORIA EN REGULAR CONDICION.
CON AJUSTE DE TTO CORTICOIDAL POR VASCULITIS, QUEDA CON PREDNISONA 1 MG KG DIA, (CON 80MG AL DIA). LOGRANDO DISMINUIR LAS LESIONES CUTANEAS DE EXTREMIDADES.
PRESENTO DIFICIL MANEJO METABOLICO, LOGRANDO ESTA SEMANA CIFRAS MAS ACEPTABLES DE GLICEMIAS, AUNQUE NO SIENDO OPTIMAS. CON ESQUEMA BASAL Y BOLOS DE INSULINA (NPH 32-20 Y CRISTALINA 8 U PRECOMIDAS)
HA MANTENIDO HEMODIALISIS 3 VECES A LA SEMANA BIEN TOLERADAS, CON HEMODINAMIA ALTERNANTE EN CUANTO A CIFRAS DE PA
DESDE PUNTO DE VISTA DE CIRUGIA, HA TENIDO SEGUIMIENTO, CON PLAN INICIAL DE ASEO QUIRURGICO EN PABELLON PARA RETIRAR BORDE NECROTICO, PERO AYER INDICAN QUE NO SE HARA Y QUE TIENE QUE SEGUIR CON CURACIONES AVANZADAS POR ENFERMERIA.
EN ESE CONTEXTO, PACTE YA FUERA DE RIESGO Y MAS ESTABLE, SIN MANEJO QXCO ACTIVO, SE DECIDE

HOPITALIZACION DOMICILIARIA PARA CONTINUAR MANEJO DE CURACIONES Y SEGUIMIENTO DE GLICEMIAS (HGT) PARA VERIFICAR INSULINOTERAPIA

PLAN DE MANEJO:

CONTROL POLI CIRUGIA AL ALTA (2 SEMANAS LUEGO DE ALTA DE HODOM), NO REQUIERE SIC, PCTE ES DE CIRUGIA ORIGINALMENTE
CONTROLES EQUIPO POSTRADOS APS (HACER EVALUACION E INGRESO AL PROGRAMA)
CONTROL MEDICINA POST ALTA
CONTROL URGENCIA HSC SOS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADA, SE ENTREGA AYUDAS TECNICAS (COLCHON, SILLA RUEDAS CON COJIN)
2. CURACIONES AVANZADAS DIA POR MEDIO (DEBRIDAMIENTO QUIMICO DE ESCARA MUÑON AMPUTACION) Y RETIRO DE PUNTOS DESDE EL LUNES 02/09 POR INDICACION DE CIRUGIA
3. REGIMEN DIABETICO HIPOSODICO
4. KINE M Y R
5. INS NPH 32U AM - 20 U PM SC
6. INS CRISTALINA 8 U PRECOMIDAS SC
7. PREDNISONA 20MG 2 C/12 HRS VO
8. ALOPURINOL 100MG 1 C/12 HRS VO
9. HIDRALAZINA 50MG 1 C/8HRS VO
10. ELCAL-D FORTE (1125/175) 1 AL DIA VO
11. CARVEDILOL 6.25MG 1 C/12 HRS VO
12. LACTULOSA 20 ML C/8 HRS SOS
13. PARACETAMOL 500MG 2 C/8HRS SOS
14. TRAMADOL 100MG 1 AL DIA SOS (ANTES DE LAS CURACIONES)

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO